

RECURSO CÍVEL Nº 5070583-13.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: JORGE VIEIRA LOPES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. COMPROVAÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA LHE DAR PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para julgar procedente a pretensão, declarando a inexigibilidade do imposto de renda sobre os proventos de inatividade da parte autora, bem como condenando a ré a devolver os valores indevidamente recolhidos de Imposto de Renda, respeitada a prescrição quinquenal, devidamente corrigidos pela SELIC, abstendo-se a fonte pagadora de descontar tal tributo dos proventos do autor. Sem honorários por se tratar de recorrente vencedor. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5070583-13.2024.4.02.5101

510015448663 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5070583-13.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: JORGE VIEIRA LOPES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso nominado do autor em face da sentença proferida pelo Juiz a *quo* (evento 83), na qual foi julgado improcedente o pedido autoral de declaração de isenção de imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria, em razão do laudo pericial ter sido conclusivo no sentido de que o autor não apresenta diagnóstico de cardiopatia grave.

Em suas razões recursais (evento 87), o autor informa que é aposentado pelo INSS desde o dia 18-06-2015, e que foi diagnosticado, em 22-10-2007, com cardiopatia grave - bloqueio atrioventricular total CID 44.2 - hipertensão arterial sistêmica - insuficiência coronariana - implante de marcapasso.

Afirma que é pacificado o entendimento jurisprudencial no sentido de que o Juízo não fica adstrito ao laudo médico oficial, uma vez que pode formar seu livre convencimento por outros meios de provas constantes nos autos.

Diz que os laudos médicos acostados aos autos, emitidos por médicos especialistas, evidenciam claramente a doença grave acometida ao recorrente e que esta situação é suficiente para que esta Colenda Turma reconheça o direito à isenção de Imposto de Renda requerida.

Menciona que foi submetido a procedimento cirúrgico de implante de marcapasso definitivo.

Gratuidade de justiça deferida para o autor (evento 03).

Contrarrazões da União no evento 90.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Foi proferida sentença pelo Juiz *a quo*, nos seguintes termos:

[...]

A análise dos exames e laudos acostados aos autos indicam, com robustez, tratar-se o autor de portador de cardiopatia, desde 2007.

No entanto, diante das informações apresentadas não é possível aferir o grau de gravidade da moléstia, razão pela qual foi determinada a realização de perícia médica por esse Juízo, diante da necessidade de consulta a especialista no tema.

*O laudo apresentado pelo perito judicial no evento **69.1** foi conclusivo no sentido de que o Autor **não preenche os critérios clínicos para diagnóstico de cardiopatia grave.***

Logo, embora comprovada a cardiopatia, não há enquadramento da moléstia suportada pelo autor no rol taxativo do artigo 6, XIV da Lei 7.713/98.

*Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.***

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios por força do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995.

[...]”

A isenção de Imposto de Renda em razão de doença grave tem como finalidade precípua possibilitar uma compensação aos contribuintes que enfrentem problemas graves de saúde e necessitem efetuar despesas não custeadas pelo Estado.

Especificamente a respeito das possibilidades de concessão de isenção de referido tributo, assim prescreve o art. 6º, da Lei nº 7.713/88:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

*XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, **cardiopatia grave**, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifo nosso).*

Compulsando os autos, verifico que o Juízo *a quo* nomeou perito judicial, a fim de ser verificado o quadro clínico do autor, que dispôs em seu laudo pericial (evento 69):

Histórico/anamnese: Adentrou a sala caminhando normalmente referindo diagnóstico de cardiopatia desde os 37 anos, com agravamento em 2007, quando passou revascularização miocárdica e com colocação de marcapasso em 2015, evoluindo com nova agudização em 2022, que foi tratada com cateterismo

Documentos médicos analisados:

A petição inicial alega que a parte autora possui "...Idoso(a) e portador(a) de doença grave (Cardiopatia Grave – Bloqueio Atrioventricular Total CID 44.2 – Hipertensão Arterial Sistêmica – Insuficiência Coronariana – Implante de Marcapasso)..."

LAUDO MÉDICO datado de 22/10/2007 indica insuficiência coronariana com lesão de tronco de 85%, submetido a cirurgia cardíaca de revascularização de miocárdio com circulação extracorpórea em 2007.

LAUDO MÉDICO datado de 13/12/2020 indica que a parte autora é portadora de marcapasso definitivo devido a quadro de CID I44.2.

LAUDO MÉDICO datado de 11/05/2015 indica hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo II, com implante de marcapasso definitivo em 05/05/2015, em acompanhamento regular com o cardiologista.

Informado que os documentos médicos arrolados e acima descritos já haviam sido avaliados, apresentou os seguintes documentos médicos a perícia.

ECOCARDIOGRAMA datado de 09/06/2022 que indica Fração de ejeção de 75%, função diastólica de VE preservada, regurgitação mitral leve

LAUDOS DE REVISÃO DE MARCAPASSO datados de 19/08/2022, 27/02/2024 e 06/08/2024 que indicam funcionamento normal

CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA datada de 16/05/2022 que indica defeito não recuperável de vascularização em parede inferior do ventrículo esquerdo, topografia da lesão antiga, sem novos sítios de isquemia



Exame físico/do estado mental:

Apresenta-se normocorada, normohidratada e normonutrida, sem sinais de doença psiquiátrica, mantendo o discurso lógico e coerente, sem déficit de atenção e ou de memória, e nem rebaixamento de humor

Aparelho respiratório: eupneico e com ritmo respiratório e ausculta pulmonar regulares

Aparelho cardiovascular: presença de marcapasso definitivo em região torácica superior direita, com ritmo cardíaco normal, bulhas normofonéticas, sem sopros e com pa 140x90 mmHg, configurando CLASSE II - NYHA

1. A pessoa periciada encontra-se acometida de alguma patologia ou deficiência? Qual(quais)? Mencionar a CID.

Hipertensão arterial – CIDX I 10.0, Presença de implantes e enxertos cardíacos e vasculares - CIDX Z95, Cardiopatia Isquêmica – CIDX I 20.0 e Diabetes Mellitus – CIDX E 10.0

2. Avaliando a deficiência, informe o perito judicial qual o impacto na limitação do desempenho de atividade e qual a restrição da participação social do periciado, compatível com a idade.

Cardiovascular moderada

3. Qual o grau de evolução da(s) patologia(s)? Fundamente, mencionando, inclusive, eventual progressão ou regressão da(s) patologia(s).

Estabilizada atualmente com progressão favorável em virtude do tratamento adequado

4. Qual a data ou época do início da(s) patologia(s)? Fundamente.

O documento médico mais antigo indica 2007

5. Caso seja constatada a incapacidade do autor, é possível dizer se esta perdurará por mais de 2 (dois) anos?

Sim, no contexto dos itens 2 e 3

7. A(s) patologia(s) que acomete(m) a pessoa periciada é (são) passível (eis) de cura, tratamento ou controle que permita a ela uma vida futura com um mínimo de sacrifício? Fundamente.

Não há cura, porém, como indicado no item 3, o questionado tratamento ou controle já foram estabelecidos

8. A doença enquadra-se como moléstia relacionada no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 1988 (tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida)?

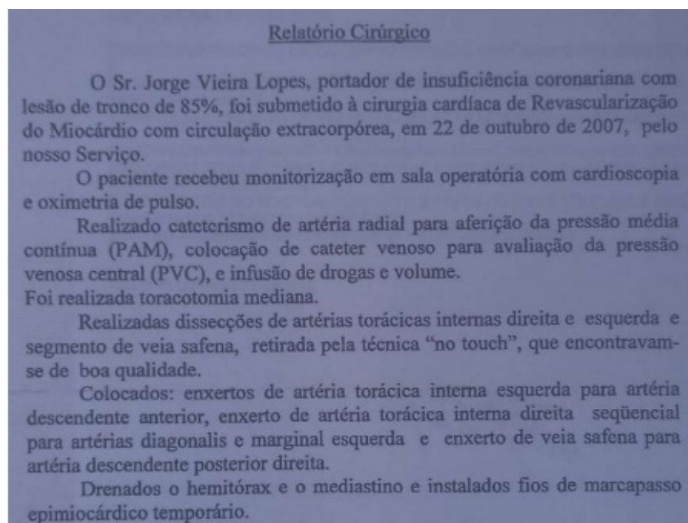
Não há sinais clínicos que indiquem Cardiopatia Grave

No mencionado laudo pericial, o perito constatou que não há sinais clínicos que indiquem cardiopatia grave.

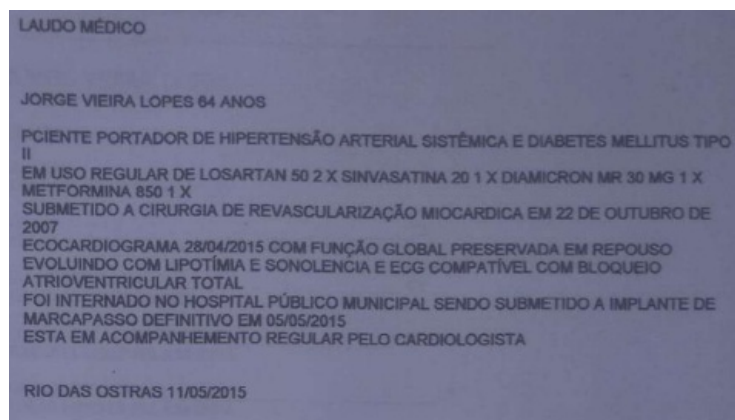
A União aduz que a cardiopatia do autor não é grave.

Todavia, verifico que há histórico de que o autor passou por cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio em 2007, com realização de cateterismo, e de que foi colocado marcapasso em 2015, conforme laudos médicos acostados aos autos, os quais atestam:

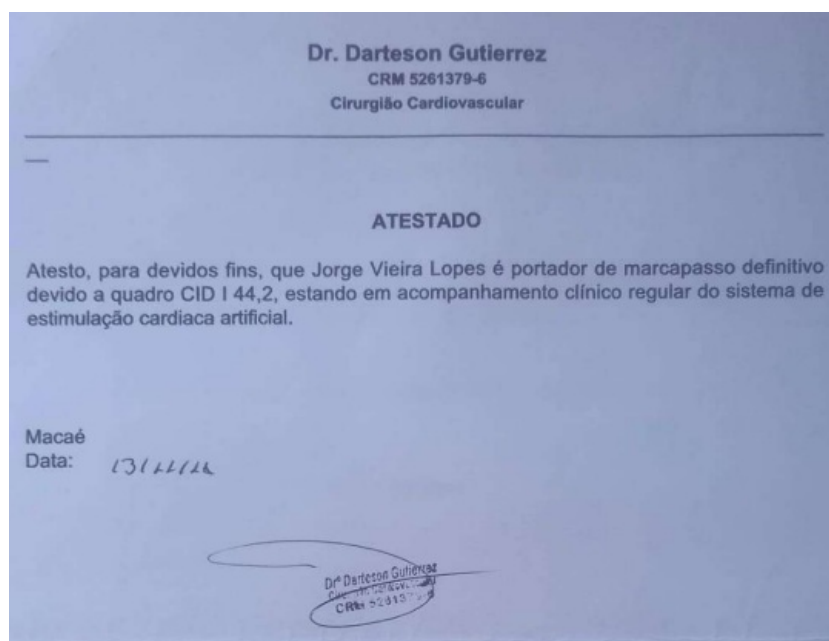
1) Laudo médico de 22-10-2007 (evento 01 - ATESTMED7): **Indica insuficiência coronariana com lesão de tronco de 85%**, submetido a cirurgia cardíaca de revascularização de miocárdio com circulação extracorpórea em 2007:



2) Laudo médico de 11-05-2015 (evento 01 - ATESTMED10): Indica hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo II, **com implante de marcapasso definitivo em 05-05-2015**, em acompanhamento regular com o cardiologista:



3) Laudo médico de 13-12-2020 (evento 01 - ATESTMED8): **Indica que a parte autora é portadora de marcapasso definitivo** devido a quadro de CID 144.2:



De acordo com a **Diretriz Brasileira de Cardiologia**, os seguintes quadros são considerados graves na cardiopatia:

a) cardiopatias agudas, habitualmente rápidas em sua evolução, que se tornam crônicas, caracterizadas por perda da capacidade física e funcional do coração;

b) as cardiopatias crônicas, quando limitam, progressivamente, a capacidade física e funcional do coração (ultrapassando os limites de eficiência dos mecanismos de compensação), não obstante o tratamento clínico e/ou cirúrgico adequado;

c) cardiopatias crônicas ou agudas que apresentam dependência total de suporte inotrópico farmacológico (como dobutamina, dopamina) ou mecânico (tipo Biopump, balão intra-aórtico);

d) cardiopatia terminal: forma de cardiopatia grave em que a expectativa de vida se encontra extremamente reduzida, geralmente não responsiva à terapia farmacológica máxima ou ao suporte hemodinâmico externo. Esses pacientes não são candidatos à terapia cirúrgica, para correção do distúrbio de base (valvopatia, cardiopatia isquêmica, cardiopatia congênita...) ou transplante cardíaco, devido à severidade do quadro clínico ou comorbidades associadas (hipertensão arterial pulmonar, disfunção renal severa, neoplasia avançada).

Cabe asseverar que, de acordo com o art. 30, caput, da Lei 9.250/1999, somente o laudo pericial emitido por serviço médico oficial poderia comprovar a moléstia grave. **Contudo, essa exigência de laudo oficial foi afastada pelo STJ**, conforme enunciado da sua Súmula nº 598:

"Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova."

Importante frisar que não é necessário que o contribuinte apresente os sintomas da doença, a incapacidade total ou a internação hospitalar para o deferimento ou manutenção da isenção. Basta que o indivíduo seja portador de uma das enfermidades listadas para obter o benefício fiscal, sendo irrelevante a evolução da doença. O objetivo da isenção é proporcionar melhores condições financeiras para que o paciente suporte o tratamento.

Esse também é entendimento do STJ, conforme enunciado de sua Súmula nº 627:

"O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. (SÚMULA 627, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)."

Ademais, a isenção de imposto de renda prevista para doenças graves é devida a partir do momento que seja identificado a caracterização da doença.

Corroborando a fundamentação acima, colaciono as jurisprudências a seguir:

TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE.

1. Há entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que, após a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o fato de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença não justifica a revogação do benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir o sacrifícios dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros.

2. Recurso especial provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.202.820 - RS (2010/0136870-5), STJ) (Grifei)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESCABIMENTO.

1. A enfermidade do autor restou comprovada através os documentos acostados e declarações médicas, que atestam claramente que o impetrante apresenta a CARDIOPATIA referida, bem como demonstram o constante tratamento da doença.

2. Comprovada a existência da doença, impõe-se a isenção do imposto de renda da pessoa portadora de moléstia grave, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88.

3. Não é possível que o controle da moléstia seja impedimento para a concessão da benesse ora postulada, posto que, antes de mais nada, deve se almejar a qualidade de vida do paciente, não sendo possível que para se fazer jus ao benefício precise o postulante estar adoentado ou recolhido a hospital, ainda mais levando-se em consideração que algumas das doenças elencadas no artigo supra citado podem ser debilitantes mas não requerem a total incapacidade do doente, como a cegueira e a síndrome de imunodeficiência adquirida.

4. Uma vez reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda.

Pois bem, no laudo médico de 2007 (evento 01 - ATESTMED7), foi constatado que o autor era portador de insuficiência coronariana com lesão de tronco de 85%; que realizou cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio em 2007, com realização de cateterismo de artéria radial para aferição da pressão média contínua; e que foram colocados enxertos de artéria torácica interna e de veia safena, ocasião em que foram instalados fios de marcapasso.

Já no laudo médico de 2015 (evento 01 - ATESTMED10), foi atestado que foi implantado marcapasso definitivo no autor em 05-05-2015, o qual foi confirmado pelo laudo médico de 2020 (evento 01 - ATESTMED8).

Desse modo, fica claro que o quadro clínico do autor é grave, conforme a alínea "c" da mencionada diretriz médica, já que a cardiopatia é crônica e exige suporte mecânico (marcapasso). Sua condição também é grave, conforme a alínea "a", já que a doença quase resultou em um infarto, evidenciando perda funcional da capacidade física do coração (autor portador de insuficiência coronariana com lesão de tronco de 85%, o qual foi submetido à cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio com circulação extracorpórea, consoante laudo médico do evento 01 - ATESTMED7).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do STJ quanto ao entendimento de haver isenção de imposto de renda acerca do uso de marcapasso, por estar caracterizada a cardiopatia grave:

Decisão

RECURSO ESPECIAL Nº 1.713.224 - PE (2017/0309731-4) RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES RECORRENTE : LUIZ BELÉM DE ALENCAR ADVOGADOS : JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO - PE003450 RAPHAEL HENRIQUE LINS TIBURTINO DOS SANTOS E OUTRO (S) - PE036816 RECORRIDO : ESTADO DE PERNAMBUCO AGRAVANTE : ESTADO DE PERNAMBUCO PROCURADORES : LEONARDO GUIMARÃES FREIRE - PE022825 LUCIANA ESPÍNDOLA AZEVEDO - PE020776 ANSELMA DE OLIVEIRA NUNES BANDEIRA DE MELLO E OUTRO (S) - PE013686D AGRAVADO : LUIZ BELÉM DE ALENCAR ADVOGADOS : JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO - PE003450 RAPHAEL HENRIQUE LINS TIBURTINO DOS SANTOS E OUTRO (S) - PE036816 TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 627/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fulcro no art. 105, inc. III, a, da CF/88, contra acórdão do Tribunal de origem, assim ementado (fl. 335): DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL MAGISTRADO APOSENTADO. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. PROVENTOS. ISENÇÃO NO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA E' DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO PRAZO DE CINCO ANOS. NECESSIDADE, DE AFERIÇÃO DO ATUAL ESTADO DE SAÚDE DO CONTRIBUINTE. MATÉRIA DE FATO E DIREITO. PROBATÓRIA QUE NÃO SE DISPENSA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO VINCULANTE. ART. 30, § 1º, DA LEI N 9.250/95. OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Os embargos de declaração foram rejeitados, conforme fls. 398-420. No seu apelo especial, a parte alega violação aos arts. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 e 30, da Lei n. 9.250/95. Argumenta que para a "manutenção do benefício fiscal, floresce irrelevante que o tumor maligno tenha sido retirado, ou que haja contemporaneidade dos sintomas da doença, razão pela qual se releva inócua e ilegal a exigência de novo exame técnico". Contrarrazões às fls. 467-489. Juízo positivo de admissibilidade à fl. 535. É o relatório. Decido. Com efeito, o Tribunal a quo consignou ser incontroverso o fato de o recorrido ter sido acometida de moléstia grave (e-STJ fl. 339). Sendo assim, o acórdão recorrido esta em desconformidade com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Acórdão regional recorrido em desconformidade com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial. Precedentes: **REsp n. 1.655.056/RS**, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe 25/4/2017; **REsp n. 1.593.845/MG**, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/5/2016, DJe 1/6/2016; e **AgRg no REsp n. 1.403.771/RS**, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 10/12/2014. II - Agravo interno improvido (**AgInt no REsp 1.732.933/DF**, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/2/2019, grifo nosso). RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO **CPC/2015**. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. DOENÇA DE CHAGAS. USO DE MARCAPASSO. CARACTERIZAÇÃO DE CARDIOPATIA GRAVE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. **A isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88 independe da contemporaneidade dos sintomas.** Precedentes: **REsp 1125064 / DF**, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; **REsp 967693 / DF**, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; **REsp 734541 / SP**, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; **MS 15261 / DF**, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em

22.09.2010. 2. Os laudos médicos oficiais ou particulares não vinculam o Poder Judiciário que se submete unicamente à regra constante do art. 131, do CPC/1973, e art. 371, do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 598/STJ: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova". 3. Situação em que o laudo médico particular faz prova ser o contribuinte portador da doença de Chagas e que, por tal motivo, faz uso de marcapasso, caracterizando a existência de cardiopatia grave, para os fins da isenção prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88. 4. Recurso ordinário provido (RMS 57058/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 13/9/2018, grifo nosso). Além do mais, a Primeira Seção desta Corte recentemente editou a Súmula n. 627, que pacificou, por derradeiro, o entendimento ora exposto, qual seja o de que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 23 de abril de 2019. Ministro BENEDITO GONÇALVES Relator. (STJ - REsp: 1713224 PE 2017/0309731-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 25/04/2019) (Grifo nosso)

Dessa forma, comprovado que a parte autora recebe proventos e que é portadora de doença grave, é de se reconhecer seu direito à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos recebidos, bem como o direito à restituição dos valores descontados indevidamente, respeitado o prazo prescricional quinquenal, conforme o art. 168 do CTN e art. 3º da Lei Complementar nº 118/2005, bem como a interpretação fixada no RE nº 566.621, julgado em repercussão geral.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA LHE DAR PROVIMENTO**, reformando a sentença recorrida para julgar procedente a pretensão, declarando a inexigibilidade do imposto de renda sobre os proventos de inatividade da parte autora, bem como condenando a ré a devolver os valores indevidamente recolhidos de Imposto de Renda, respeitada a prescrição quinquenal, devidamente corrigidos pela SELIC, abstendo-se a fonte pagadora de descontar tal tributo dos proventos do autor. Sem honorários por se tratar de recorrente vencedor. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem. É como voto.